

ID Paciente: P002

NHC: NHC-2021-009344

Generado: 09/04/2026

HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

1. Datos del paciente

Nombre completo	Miquel Àngel Roca Fuster
Sexo	Hombre
Fecha de nacimiento	29/07/1972 (52 años)
DNI	20.143.876-F
Teléfono	699 210 543
Municipio	Benicàssim
Médico responsable	Dr. Jordi Palau Gimeno
Especialidad	Cardiología

2. Antecedentes personales

- Infarto agudo de miocardio SCASEST (octubre 2021) — stent en DA proximal
- Hipertensión arterial esencial (diagnóstico 2018)
- Dislipemia aterogénica
- Tabaquismo activo (20 cigarrillos/día, IPA 30)
- Sedentarismo marcado (trabajo de oficina)
- No diabetes. No alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes familiares: Padre: IAM a los 54 años. Hermano mayor: angina estable.

3. Historia clínica

Paciente de 52 años con antecedente de IAM-SCASEST hace 3 años, revascularizado con stent farmacoactivo en arteria descendente anterior proximal. Actualmente en seguimiento por cardiología. Refiere buena tolerancia al esfuerzo sin angina de reposo ni disnea. Cumplimiento farmacológico bueno según declaración propia. Persiste tabaquismo activo pese a consejo médico repetido. Ocasionalmente olvida la medicación anticoagulante. Sin episodios de sangrado ni equimosis llamativas. Control tensional aceptable en domicilio (130-140/80-88 mmHg).

4. Exploración física

Peso / Talla / IMC	88 kg · 178 cm · 27,8 kg/m ²
Tensión arterial	138/84 mmHg (brazo izquierdo, sedestación)
Frecuencia cardíaca	68 lpm, rítmica
Temperatura	36,6 °C
Saturación O2	96 % (aire ambiente)

Auscultación cardiaca	Tonos rítmicos. Soplo sistólico eyectivo I/VI en foco aórtico
Auscultación pulmonar	Murmullo vesicular conservado bilateralmente
Abdomen	Sin hallazgos relevantes. No hepatomegalia
MMII	Sin edemas. Pulsos femorales y poplíteos presentes

■ 5. Tratamiento farmacológico actual

Medicamento	Posología
AAS 100 mg	1 comp. con desayuno (antiagregación doble)
Ticagrelor 90 mg	1 comp. cada 12 h
Bisoprolol 5 mg	1 comp. en desayuno
Ramipril 10 mg	1 comp. en desayuno
Rosuvastatina 40 mg	1 comp. en cena
Ezetimiba 10 mg	1 comp. en cena
Pantoprazol 40 mg	1 comp. en ayunas

■ 6. Nota de seguimiento — 05/03/2025

Motivo de consulta	Control semestral post-IAM — revisión cardiológica
--------------------	--

Subjetivo (anamnesis):
El paciente acude solo a la consulta. Niega angina de esfuerzo o reposo. Refiere disnea leve con grandes esfuerzos (subir 4 pisos) que atribuye al tabaquismo. Sin palpitaciones ni síncope. Persiste tabaquismo activo; refiere intención de dejar de fumar pero no ha iniciado ninguna terapia de deshabituación. Buen cumplimiento declarado del resto de la medicación. Actividad física escasa: únicamente desplazamientos a pie al trabajo.

Objetivo (datos clínicos):
ECG: ritmo sinusal a 68 lpm. Eje normal. No alteraciones de la repolarización. Ecocardiograma (enero 2025): FEVI 52%, hipocinesia leve segmento anteroseptal basal, sin derrame pericárdico. LDL-c 68 mg/dL (objetivo cumplido). TA 138/84 mmHg.

Plan terapéutico:

- Mantener doble antiagregación hasta completar 36 meses post-stent (octubre 2024: ya completado). Valorar monoterapia antiagregante con AAS.
- Solicitar ergometría de esfuerzo máximo para valorar tolerancia y detección de isquemia residual.
- Insistir en deshabituación tabáquica: derivar a unidad de tabaquismo.
- Mantener objetivo LDL-c < 55 mg/dL (riesgo muy alto). Valorar inhibidor PCSK9 si no se alcanza.
- Control analítico completo en 3 meses.
- Próxima revisión en 6 meses (septiembre 2025).

■ 7. Resultados de laboratorio — 01/03/2025

Parámetro	Resultado	Referencia	Flag	Unidades
Glucosa basal	98	70 – 100	N	mg/dL
HbA1c	5,4	< 5,7	N	%

Colesterol total	148	< 200	N	mg/dL
LDL-c	68	< 55 (risg muy alto)	H	mg/dL
HDL-c	41	> 40	N	mg/dL
Triglicéridos	195	< 150	H	mg/dL
Creatinina	1,05	0,70 – 1,20	N	mg/dL
FGe (CKD-EPI)	72	≥ 60	N	mL/min/1,73m ²
PCR ultrasensible	2,8	< 1,0	H	mg/L
NT-proBNP	310	< 125	H	pg/mL
Troponina T hs	14	< 19	N	ng/L
Hemoglobina	15,2	13,5 – 17,5	N	g/dL
Plaquetas	224	150 – 400	N	x10 ³ /μL

Observaciones: LDL-c 68 mg/dL: por encima del objetivo en riesgo muy alto (< 55 mg/dL). NT-proBNP ligeramente elevado, compatible con disfunción sistólica leve conocida. PCR elevada sugiere inflamación crónica; se relaciona con tabaquismo activo. Hipertrigliceridemia persistente: reforzar medidas dietéticas y valorar fibratos.

Documento de uso exclusivo para investigación. Todos los datos son ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de información biomédica y clínica.